

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

DIACOL 27 mg/15 ml sirop

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare 15 ml sirop conține bromhidrat de dextrometorfan 27 mg.

Pentru lista tuturor excipientilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Sirop

4. DATE CLINICE

4.1. Indicații terapeutice

Pentru ameliorarea temporară a tusei uscate, cauzată de iritația tractului respirator superior sau inferior.

4.2. Doze și mod de administrare

Se recomandă următoarea schemă de dozare:

Adolescenți, vârstnici și adulți: câte 15 ml la fiecare 6-8 ore. Doza maximă nictemerală constituie 60 ml.

Copii cu vârsta între 2 și 12 ani: dozele se administrează în funcție de indicațiile medicului. Doza maximă nictemerală pentru copii cu vârsta între 6-12 ani constituie 30 ml, pentru copii cu vârsta între 2-6 ani – 15 ml.

Copii cu vârsta sub 2 ani: nu se recomandă administrarea preparatului la această grupă de vârstă.

DIACOL poate fi administrat la fiecare 4 ore, reducând cantitatea de sirop la o priză, astfel încât să nu depășească doza zilnică maximă.

A nu se depăși dozele recomandate sau nu se va utiliza în mod continuu pentru perioade lungi de timp.

4.3. Contraindicații

Hipersensibilitate la oricare dintre componentele DIACOL.

Tusea productivă (cu expectorație).

Tratamentul concomitent cu inhibitori ai monoaminooxidazei.



4.4. Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

DIACOL se va administra cu precauție la pacienții cu astm bronșic sau astm bronșic atopic, deoarece poate declanșa eliberarea de histamină.

Se va administra cu precauție la pacienții sedați sau astenizați.

La pacienții cu insuficiență hepatică poate fi înregistrată modificarea metabolismului.

Au fost raportate cazuri de abuz și dependență de dextrometorfan. Se recomandă, în mod deosebit, atenție în cazul adolescenților și al tinerilor, precum și al pacienților cu antecedente de consum de droguri sau substanțe psihoactive.

Dacă tusea persistă mai mult de o săptămână, iar simptomele bolii sunt însoțite de febră sau recurență de febră, erupții cutanate, cefalee intensă, pacientul trebuie să fie consultat de către medic.

DIACOL conține 121,64 g **zaharoză** în 200 ml sirop. Fiecare 15 ml conțin aproximativ 9,1 g zaharoză. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la fructoză, sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză sau insuficiență a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest medicament.

DIACOL conține 2,75 g de **etanol 96%** în 200 ml sirop. Fiecare 15 ml conțin aproximativ 0,20 g de etanol 96%. Poate fi dăunător pentru pacienții care suferă de alcoolism, boli hepatice, epilepsie sau boli cerebrale sau leziuni, precum și pentru femeile gravide, și copii. Poate modifica sau intensifica efectele altor medicamente.

Dextrometorfanul este metabolizat prin intermediul citocromului hepatic P450 2D6. Activitatea acestei enzime este determinată genetic. Aproximativ 10% din populația generală sunt metabolizatori slabi ai CYP2D6. Metabolizatorii slabi și pacienții care administrează concomitent inhibitori ai CYP2D6 pot prezenta efecte exagerate și/sau prelungite ale dextrometorfanului. Prin urmare, ar trebui să se acorde atenție pacienților care sunt metabolizatori lenți ai CYP2D6 sau care administrează inhibitori ai CYP2D6 (vezi, de asemenea, pct. 4.5).

Sindromul serotoninergic

A fost raportată apariția efectelor serotoninergice, inclusiv dezvoltarea unui sindrom serotoninergic potențial letal, în cazul administrării concomitente a dextrometorfanului cu medicamente cu efect serotoninergic, cum ar fi inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), medicamentele care influențează metabolizarea serotoninei (incluzând inhibitorii monoaminoxidazei (IMAO)) și inhibitorii CYP2D6.

Simptomele sindromului serotoninergic pot include modificări ale stării mentale, instabilitate vegetativă, tulburări neuromusculare și/sau simptome gastrointestinale.

În cazul în care se suspectează instalarea sindromului serotoninergic, tratamentul cu DIACOL trebuie întrerupt.

Populația pediatrică

La copii pot să apară reacții adverse grave în caz de supradozaj, inclusiv tulburări neurologice. Persoanele care au grijă de pacienți trebuie avertizate să nu depășească doza recomandată.

4.5. Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Administrarea concomitentă de DIACOL și inhibitori de monoaminooxidază (IMAO) poate declanșa crize adrenergice, comă, amețeli, excitabilitate, hipertensiune arterială, hiperpirexie, hemoragie intracerebrală, letargie, greață, comportament psihotic, spasme musculare, tremor și, eventual, sfârșit letal, prin urmare administrarea concomitentă este contraindicată. După întreruperea administrării inhibitorilor MAO și inițierea administrării de dextrometorfan trebuie respectat un interval de 14 zile.

La administrarea concomitentă de dextrometorfan și deprimante ale sistemului nervos central pot apărea efecte aditive.

Dextrometorfanul este metabolizat de către CYP2D6 și este supus unei metabolizări extensive la primul pasaj hepatic. Administrarea concomitentă a inhibitorilor puternici ai enzimei CYP2D6 poate crește concentrațiile de dextrometorfan în organism la niveluri mult mai mari decât valorile normale. Acest lucru crește riscul de apariție a efectelor toxice ale dextrometorfanului (agitație, confuzie, tremor, insomnie, diaree și deprimare respiratorie) și dezvoltarea sindromului serotoninergic. Inhibitorii potenți ai enzimei CYP2D6 includ fluoxetina, paroxetina, chinidina și terbinafina. În cazul utilizării concomitente cu chinidina, concentrațiile plasmatice ale dextrometorfanului au crescut de până la 20 de ori, ceea ce a condus la creșterea efectelor adverse ale dextrometorfanului la nivelul SNC.

Amiodarona, flecainida și propafenona, sertralina, bupropiona, metadona, cinacalcet, haloperidol, perfenazina și tioridazina, de asemenea, prezintă efecte asupra metabolizării dextrometorfanului.

Dacă administrarea concomitentă a inhibitorilor CYP2D6 și a dextrometorfanului este necesară, pacientul trebuie monitorizat și doza de dextrometorfan poate fi necesar să fie redusă.

4.6. Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Deși nu există date documentate privind efectele asupra fătului secundare administrării de DIACOL în timpul sarcinii sau orice date care descriu orice tip de interferență cu sistemul reproductiv, administrarea DIACOL nu este recomandată în timpul sarcinii. De asemenea, DIACOL nu trebuie administrat în perioada de alăptare.

4.7. Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Nu se cunosc interacțiuni la utilizarea dozele terapeutice recomandate.

4.8. Reacții adverse

Acestea sunt rare, pot exista tulburări ușoare ale tractului gastrointestinal, cum ar fi greață, vărsături și dureri epigastrice, amețeli și vertij.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Aceasta permite monitorizarea în continuare a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate,



prin intermediul sistemului național de raportare disponibil pe site-ul oficial al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: www.amdm.gov.md sau email: farmacovigilenta@amdm.gov.md

4.9. Supradozaj

Simptome și semne:

În caz de supradozaj cu dextrometorfan pot să apară greață, vărsături, spasme musculare, agitație, confuzie, somnolență, apatie, nistagmus, toxicitate cardiacă (tahicardie, ECG anormal, inclusiv prelungire a intervalului QTc), ataxie, psihoză toxică cu halucinații vizuale, hiperexcitabilitate.

În cazul unui supradozaj masiv, pot să apară următoarele simptome: comă, deprimare respiratorie, convulsii.

Abordare terapeutică:

- Pacienților asimptomatici care au ingerat doze de dextrometorfan mai mari decât cele recomandate în ultima oră li se poate administra cărbune activat.
- În cazul pacienților care au ingerat dextrometorfan și sunt sedați sau în comă, se poate lua în calcul administrarea de naloxonă, în dozele uzuale pentru tratamentul supradozajului cu opioide. Se pot utiliza benzodiazepine pentru convulsii și benzodiazepine și măsuri externe de scădere a temperaturii corporale pentru hipertermia din cadrul sindromului serotoninergic.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1. Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antitusive, exclusiv combinații cu expectorante, alcaloizi din opiu și derivați. Codul ATC: R05DA09.

Dextrometorfanul este un antitusiv cu acțiune centrală. Este un izomer al levorfanolului, un analog al codeinei. Spre deosebire de alți izomeri, dextrometorfanul nu posedă proprietăți analgezice, nu determină dependență și nu acționează asupra receptorilor opioizi.

Proprietățile antitusive sunt rezultatul acțiunii sale directe la nivelul centrului de tuse în măduva spinării, prin creșterea pragului reflexului de tuse. Acțiunea sa antitusivă este similară cu cea a codeinei și efectele durează timp de 6 ore. Spre deosebire de codeină, efectele sedative ale dextrometorfanului sunt esențial neglijabile și se înregistrează numai la administrarea dozelor mari. La dozele recomandate, nu inhibă motilitatea cililor mucoasei tractului respirator, care este un avantaj în comparație cu alte medicamente antitusive.

5.2. Proprietăți farmacocinetice

Dextrometorfanul se absoarbe rapid din tractul gastrointestinal. Timpul până la atingerea concentrației plasmatice maxime (T_{max}) este de 2 până la 2,5 ore și concentrația plasmatică maximă (C_{max}) după administrarea unei singure doze de 60 mg constituie 5,2 ng/ml. Debutul efectului antitusiv apare după 15 până la 30 de minute după administrare și durează între 5 și 6 ore.

Dextrometorfanul se distribuie în sistemul nervos central, realizând concentrații detectabile în lichidul cefalorahidian (LCR). În studiile efectuate pe animale raportul concentrației LCR/plasmă variază între 32,8 și 80%.

După administrarea orală dextrometorfanul este metabolizat rapid și extensiv în timpul primului pasaj hepatic. O-demetilarea controlată genetic (CYD2D6) este principala determinantă a proprietăților farmacocinetice a dextrometorfanului la voluntari.

Se pare că există fenotipuri distincte pentru acest proces de oxidare care determină proprietăți farmacocinetice foarte variabile între subiecți. Dextrometorfanul nemetabolizat, împreună cu cei trei metaboliți de morfină demetilați (cunoscut și sub numele de 3-hidroxi-N-metilmorfinan), 3-hidroximorfinan și 3-metoximorfinan au fost identificați ca produși conjugați în urină.

Dextrofanul, care are și acțiune antitusivă, este principalul metabolit. La unii indivizi, metabolismul are loc mai lent și dextrometorfanul sub formă nemodificată predomină în sânge și urină.

Dextrometorfanul și metabolitul său demetilat se excretă în urină. Timpul de înjumătățire prin eliminare al dextrometorfanului este de 1,4 până la 3,9 ore, iar al dextrofanului – 3,5 până la 5,6 ore.

5.3. Date preclinice de siguranță

Dextrometorfanul este un medicament utilizat curent și este inclus în aproape toate farmacopeile.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1. Lista excipienților

Zaharoză
Acid citric anhidru
Metilparaben
Aromă lichidă de portocale
Etanol
96%
Apă
purificată

6.2. Incompatibilități

În absența unor studii de incompatibilitate, acest medicament nu trebuie să fie amestecat cu alte medicamente.

6.3. Perioada de valabilitate

60 luni

După prima deschidere a flaconului: 48 luni.

6.4. Precauții speciale de păstrare

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.



6.5. Natura și conținutul ambalajului

Cutie de carton cu un flacon de sticlă tip III de culoarea brună și prospectul.
Ambalajul include și un pahar dozator. Flaconul conține 200 ml sirop.

6.6. Precauții speciale pentru utilizare și manipulare (și distrugere)

Fără cerințe speciale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

BIAL - Portela & C^a, S.A.

À Avenida da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado,
Portugalia

8. NUMĂRUL(ELE) CERTIFICATULUI(LOR) DE ÎNREGISTRARE

25477

9.DATA AUTORIZĂRII

04.04.2019

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Decembrie 2020

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>